

INDICADO POR: Dr. Maria
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

ALBERTO SAKAE TATEI

IDADE: 73 PESO: 70 ALTURA: 1,70 PROFISSÃO: Aposentado (Fiscal Receita Federal)
SINTOMAS: Sonolência diurna, cansaço, alteração humor.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Atenolol / Vaslip.

MÉDICO: Dr. Mário Sérgio L. Carneiro

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates 2x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 19h

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 4:30 - 5:30

COCHILHO () S () N 1h30 DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 48,6 cm/h SPO2: 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / Colesterol

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☒ S () N SPO2 C/ CPAP: 88% PRESSÃO NO EXAME: 9 cmH₂O

10/12/24 $P = 6 - 10 \text{ cmH}_2\text{O}$ *Localização*
max dream wear (M)
Natacha

17/12/24 $P = 6,2 - 7,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 IAH = 4,8
M. de uso: 6h 19'
fuga = 15,4 lpm

27/12/24 $P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$ $P_{90} = 7,6 \text{ cmH}_2\text{O}$ boca seca
IAH = 1,3 l/h
M. de uso = 5h 50 min
fuga = 29 l/min. P fixa: 6,4 cmH₂O Silvia

08/01/25 $P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$ Bem adaptado
IAH = 1,6 l/h
M. de uso: 6h 33'

Sua Cláudio

29/03/25 $P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 1,6 \text{ el/h}$

medu: 6h16'

fuga: 5,5 l/m

Bem adaptada

Natasha

26/02
25

$P = 6,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 4,6 \text{ el/h}$

medu: 6h45'

fuga: 17,4 l/m

Bem adaptado

Siqueiros

Natasha

14/04/25

$P = 6,8 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 5,0 \text{ el/h}$ 4,4 el/h

medu: 6h22 min

fuga: 11 l/min

Silvii

Nome: ALBERTO SKAE TATEI

Data de Nascimento: 7-5-1951

IMC: 24,57

Sexo: Masculino

Data do exame: 21-09-2024

Peso: 71 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DR. HENRIQUE PEDRO MAGOGA

FILHO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 21-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 429,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,0 e 140,0 minutos. O tempo total de sono foi de 342,0 min, eficiência de 79,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 71,8%; estágio N3: 12,0%; sono REM: 14,3%. O índice de despertares foi de 33,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 48,6/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 170 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 86%, permanecendo 2,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 70 bpm e NREM de 51 - 73 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 48,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

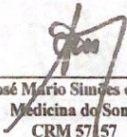
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157